

On va étudier la mise en place du tractus gastro-intestinal et de la cavité péritoneale et du péritoine dans le mouvement du développement de l'estomac, du diodénome, de l'intestin et du côlon. On va commencer par le comprendre dans le développement de l'estomac en rapport avec le foie et la rate et le pancréas. Comprendons bien la phase initiale, ce qu'on appelle la délimitation de l'embryon. On a vu l'intégration de ce cellome externe en un cellome interne. Nous arrivons à ce stade-ci. Et là, on voit à la fois dans le côté sagittal et dans le côté transversal. On voit bien l'intégration de ma cavité péritoneale. N'oubliez pas la synchronicité de développement. Encore une dernière image pour voir cette intégration. Le grand moteur, c'est la croissance, c'est la formation de notre corte, mais à ordre primitif. La croissance globale de mon embryon, l'enroulement et le retour vers ma ligne médienne. Quand vous prenez un petit bébé, vous le prenez dans les mains et il vous montre toute l'histoire de son embryologie. Il n'y a qu'à suivre les tissus. C'est un mouvement tridimensionnel à quatre et même à la cinquième dimension. J'entends par quatrième dimension le temps. La cinquième dimension, j'entends que c'est cette composante énergétique, électrique, globale qui sous-entend tout le système. N'oubliez pas que ce mouvement est toujours intégré dans cette phase d'ascension de mon ectoderme et de descente relative de mon endoderme, avec cette phase presque au niveau du cœur. L'ascension de l'ectoderme et la descente de l'endoderme et l'intégration du cœur étirent les bages de la musculature diaphragmatique et de celles des futurs muscles antérieurs du cou. Ça veut dire que pour traiter et réorganiser tout cet espace, il faudra comprendre qu'il faudra traiter et libérer le diaphragme. Parce que c'est lui qui va créer cette délimitation globale. L'ascension de mon tube neural, le développement de ma cavité péritoneale, la mise en place de mon cœur est un mouvement qui va se réintégrer globalement vers un point d'appui qu'on appelle

le cordon ombilical. On pourrait dire que le cordon ombilical, dans sa finalité, contient l'histoire de ce développement, de ce déroulement, de cette délimitation, de cette réorganisation de ton péritoine. Ça va s'intégrer dans des mouvements de rotation spécifiques, organisés, dans des sens horaires et anti-horaires bien spécifiques. Sur un plan frontal, on va voir un mouvement de développement global anti-horaire. Sur un plan transversal, on va voir un mouvement de développement horaire. Cette cavité péritoneale va commencer à s'organiser, à se délimiter. Ça veut dire qu'elle va bouger. Et dans ce mouvement, il faudra apprendre à suivre ce développement. Il y a d'abord le péritoine qui entoure un organe. Ça s'appelle un péritoine viscéral. Quand un péritoine relie un organe à la partie postérieure, ça s'appelle un méso. Si c'est l'estomac, ça va s'appeler un mésogaste. Si c'est le duodénum, ça va s'appeler le mésoduodénum. Si c'est un colon, ça va s'appeler le mésocolon. Ou, en fonction de la localisation, ça va s'appeler un fascia de Tholt, par exemple. Mais si c'est un intestin grêle, ça s'appelle un mésentère. Péritoine qui est ici à la partie postérieure, ça s'appelle le péritoine pariétal postérieur. Au niveau latéral, ça s'appelle le péritoine pariétal postérieur. Au niveau latéral, ça s'appelle le péritoine pariétal antérieur. Si c'est un péritoine qui relie un organe à un autre organe, ça s'appelle un épiploque. Par exemple, vous avez le petit épiploque. C'est un tissu qui relie le foie à l'estomac. Vous avez aussi un épiploque qui relie la rate à l'estomac. Un épiploque, un méso, c'est toujours une double lame qui porte en plein milieu un vaisseau. Dans le mouvement développemental, on va voir qu'il va y avoir des replis et une réorganisation qui fait que l'épiploque qui est ici, par exemple le méso, va pouvoir venir sur le côté comme ceci. Et donc ici, il y a un tissu qui va s'attacher et ça va former un fascia d'accolement. C'est quelque chose que les chirurgiens peuvent réséquer sans problème parce qu'il n'y a pas de vaisseau. Un méso, ça contient toujours un vaisseau. Tandis qu'un

ligament ou un fascia, ça ne contient pas spécialement de vaisseau. Au niveau du péritone, on va avoir le mésoderme, la somatopleure, la splanchnopleure, le mésogastrome, ventrale, dorsale. Et on va avoir ce qu'on appelle des méso, des fascia, des omentum qu'on appelle des épiplombs ou des ligaments. Tout ça, c'est du péritone, on va dire, au départ, organisé dans la cavité péritonéale, je parle. Il y a mon intestin qui va commencer à grandir, il y a mon foie qui va se développer, il y a mon estomac qui veut s'exprimer, il y a mes poumons qui poussent. Tout ça, il faut que ça trouve sa place.